SaludPlus Obra Social

Salud · Red de centros médicos ambulatorios

PROYECTO Sistema de Turnos, Admisión y Gestión de Sala de Espera

SaludPlus es una obra social de alcance provincial con 190.000 afiliados que administra, además, una red propia de 6 centros médicos ambulatorios: cuatro en la capital provincial y dos en el interior. Cada centro concentra consultorios externos de unas 20 especialidades, laboratorio de extracciones y un sector de diagnóstico por imágenes.

Los centros atienden en promedio 1.800 consultas diarias entre los seis. El pico de atención se concentra entre las 7:00 y las 11:00, cuando conviven pacientes con turno programado, pacientes de demanda espontánea, personas que solo vienen a retirar un estudio y afiliados que van a hacer un trámite administrativo. Todos hacen la misma cola.

En 2024 SaludPlus compró un módulo de turnos web enlatado a un proveedor externo. Funciona a medias: los pacientes sacan el turno online, pero al llegar al centro el sistema no sabe que llegaron. La secretaria imprime el listado del día a la mañana y lo va tachando con birome. El proveedor no entrega el código ni permite modificaciones, solo vende módulos adicionales.

190.000 AFILIADOS	**6 (4 capital · 2 interior)** CENTROS MÉDICOS	**~1.800** CONSULTAS DIARIAS	**~20 por centro** ESPECIALIDADES
140 (mayoría part-time) MÉDICOS	**24** SECRETARIAS DE ADMISIÓN	**27%** AUSENTISMO ACTUAL	**07:00 a 11:00** PICO DE DEMANDA

01 CÓMO SE TRABAJA HOY

El siguiente es el circuito real que hoy ejecuta la organización. No hay sistema que lo soporte de forma integral: lo que se describe es lo que efectivamente ocurre.

— El paciente saca turno por la web del proveedor externo, por teléfono (call center de 6 personas) o presencialmente.

— Al llegar al centro se anuncia en un mostrador de admisión. La secretaria lo busca en el listado impreso, lo tacha y le dice que espere.

— Cuando el médico está listo, sale al pasillo y llama al paciente por su nombre en voz alta. En los pasillos más largos, la gente no escucha.

— Si el médico se atrasa, nadie informa nada. Los pacientes se acercan al mostrador a preguntar, lo que interrumpe a la secretaria y demora todavía más.

— Los pacientes de demanda espontánea se anotan en un cuaderno y se los intercala 'como se puede'.

— El ausentismo a turnos programados es del 27% y nadie lo mide sistemáticamente: se estima a ojo.

02 ACTORES INVOLUCRADOS

Cada actor tiene intereses propios y no siempre alineados con los del resto. Identificar quién decide, quién usa y quién sufre el problema es parte del análisis.

Director Médico	Sponsor del proyecto. Le importan los tiempos de espera y la ocupación de consultorios. Muy ocupado, disponible sólo por videollamada.
Secretarias de admisión (24)	Usuarias más intensivas del sistema. Trabajan bajo presión, con el paciente enfrente. Perfiles etarios y de alfabetización digital muy diversos.
Médicos (140, la mayoría part-time)	Rotan entre centros. No quieren 'cargar datos'. Si el sistema les agrega un clic de más, no lo usan.
Pacientes / afiliados	Población muy heterogénea: desde adultos mayores sin smartphone hasta usuarios que quieren resolver todo desde el celular.
Área de Sistemas de SaludPlus	Dos personas. Administran la infraestructura y son quienes van a heredar el sistema. Tienen opinión fuerte sobre tecnologías.
Auditoría / Legales	Controla el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y de historia clínica.

03 PROBLEMAS DETECTADOS

— Tiempos de espera reales desconocidos: no hay ningún dato duro, sólo quejas.

— El llamado a viva voz genera confusión, pérdida de turnos y reclamos de pacientes con hipoacusia.

— La secretaria es un cuello de botella: atiende admisión, consultas de espera, teléfono y trámites al mismo tiempo.

— El médico no sabe cuántos pacientes tiene esperando ni si el siguiente ya llegó.

— Ausentismo del 27% que deja consultorios vacíos mientras hay lista de espera de 40 días para algunas especialidades.

— El módulo comprado no se integra con nada y el proveedor cobra por cada cambio.

— Cero indicadores: la dirección no puede responder 'cuánto se espera en promedio en el centro de Villa Norte un martes a las 9'.

04 LA VOZ DEL CLIENTE

Frases textuales recogidas durante las primeras entrevistas. Detrás de cada una hay un requerimiento —a veces funcional, a veces no funcional— que el equipo debe interpretar y formalizar.

> *«Quiero que el paciente entre, se anuncie solo, se siente y sepa cuánto le falta. Y que la secretaria pueda respirar.»*

> *«Los médicos no me van a usar nada que les lleve tiempo. Si tienen que cargar algo, lo van a dejar para el final del día y va a quedar mal cargado.»*

> *«Tengo pacientes de 80 años. Si el sistema depende de que todos tengan celular, no sirve.»*

«Hay datos de salud acá adentro. Si eso se filtra, el problema no es informático, es judicial.»

«No puedo cerrar el centro para instalar un sistema nuevo. Tiene que convivir con lo que hay.»

05 RESTRICCIONES Y CONDICIONES DEL CONTEXTO

— El sistema debe convivir con el módulo de turnos web del proveedor externo, que no se puede modificar y expone sólo una API de consulta limitada y poco documentada.

— Normativa de protección de datos personales y de datos sensibles de salud: trazabilidad de accesos, consentimiento, resguardo y política de retención.

— La operación no puede detenerse: cualquier despliegue tiene que ser progresivo, centro por centro, sin ventana de corte.

— Los 6 centros tienen infraestructura desigual: dos tienen fibra óptica y wifi estable; el del interior tiene conexión inestable y cortes frecuentes.

— Presupuesto anual cerrado y ya aprobado. No hay margen para ampliaciones durante el ejercicio.

— Se requiere accesibilidad real: contraste, tamaño de tipografía, lectura a distancia en pantallas de sala de espera, y alternativa para quien no tiene smartphone.

06 POR QUÉ LA DECISIÓN NO ES OBVIA

Este es el núcleo del caso. Cada punto tensiona la elección metodológica en una dirección distinta. El equipo deberá explicar cómo su propuesta resuelve —o al menos administra— cada una de estas tensiones.

01 Hay tres interfaces con lógicas de uso opuestas: un tótem/kiosco de autogestión para el paciente, un panel operativo denso para la secretaria y una vista mínima de un solo clic para el médico. Diseñar y validar las tres a la vez no es trivial.

02 El requerimiento normativo (datos de salud) es rígido y debe estar bien desde el día uno; el requerimiento de experiencia (cómo llamar al paciente) sólo se puede validar probando con gente real.

03 El usuario que decide (Director Médico) no es el usuario que usa (secretaria), y el usuario que usa no es el que sufre el problema (paciente).

04 La integración con un sistema de terceros cerrado introduce una dependencia externa que el equipo no controla.

05 Un despliegue centro por centro obliga a que el sistema soporte convivir consigo mismo en dos versiones distintas al mismo tiempo.

06 La conectividad inestable de un centro obliga a decidir tempranamente si la solución es local, en la nube o híbrida: es una decisión de arquitectura difícil de revertir.

07 NECESIDADES FUNCIONALES EXPRESADAS POR EL CLIENTE

Lo que sigue es lo que el cliente pidió, no el alcance del proyecto. Definir el alcance —qué entra, qué queda fuera y en qué orden— es responsabilidad del equipo y debe quedar plasmado en el Contrato de Alcance.

— Kiosco / tótem de autogestión: el paciente se anuncia con DNI o número de afiliado y recibe su número de orden.

— Pantalla de sala de espera: muestra el turno llamado, el consultorio y el tiempo estimado. Debe leerse a 8 metros.

— Panel de secretaría: cola en tiempo real, gestión de demanda espontánea, reprogramaciones, prioridades y alertas.

— Vista del profesional: 'llamar al siguiente' en un clic, con la mínima carga de datos posible.

— Tablero de indicadores: tiempo de espera real, ausentismo, ocupación de consultorio, demora por especialidad y por centro.

— Módulo de notificaciones y recordatorios de turno para bajar el ausentismo.

— Registro de auditoría de accesos a datos sensibles.

08 IDENTIDAD VISUAL DE LA MARCA

La solución debe respetar la identidad de SaludPlus Obra Social. La paleta base es la siguiente; el equipo deberá completarla en su Manual de Marca con tipografías, escala tipográfica, grilla, estados semánticos, iconografía y componentes base. Los colores pueden ajustarse siempre que se justifique la decisión y se cumplan los contrastes mínimos de accesibilidad.

Primario	**Secundario**	**Acento**	**Fondo**
#0A6EBD	#0B2440	#0D9488	#F4F8FC
Azul confianza	*Azul noche*	*Teal cuidado*	*Celeste muy claro*

09 PREGUNTAS QUE HARÁ EL CLIENTE EN LA DEFENSA

El docente asumirá el rol de cliente y Product Owner. Estas preguntas se harán durante la defensa; pueden aparecer otras. No alcanza con haberlas leído: hay que poder responderlas con evidencia del propio trabajo.

«Tengo un centro con internet que se cae tres veces por semana. ¿Qué pasa con la sala de espera cuando eso ocurre?»

«¿Cómo me garantizan que un dato de salud no queda accesible para quien no corresponde?»

«¿Qué hacen si el proveedor del módulo de turnos cambia su API en el medio del proyecto?»

«Mis secretarias tienen entre 24 y 61 años. ¿Cómo saben que la pantalla que diseñaron les va a funcionar a las dos?»

«¿En qué orden despliegan los centros y por qué? ¿Qué pasa si el primero sale mal?»

Caso B · SaludPlus Obra Social · Las consignas, entregables y criterios de evaluación se encuentran en el documento de la Instancia Evaluativa N°2.